Les limites de la loi Bertrand

En 2011, la transparence des liens d'intérêts était une mesure phare de la loi Bertrand. Gérée par le ministère, elle reste perfectible

En 2011, la loi Bertrand a initié un dispositif inédit en France. Il s'agissait d'obliger les industriels à rendre publics leurs liens d'intérêts avec les professionnels de santé à travers la base Transparence santé, mise en ligne par l'État. Le but ? Que chacun puisse connaître les liens entretenus par un médecin avec un laboratoire. Aucun autre secteur d'activité n'a fait l'objet d'un dispositif aussi détaillé et intrusif. Pour autant, l'objectif a-t-il été atteint ? Pas sûr.

« En France, rien ne se fait contre l'industrie pharmaceutique. Les règles fixées sont un progrès. Mais si les labos les ont acceptées, c'est qu'elles ne troublent pas les jeux profonds. L'industrie avait anticipé que la promotion ne se ferait plus par la visite médicale à la papa, mais dans des sphères plus opaques, auprès des leaders d'opinion, des associations de malades, et même des startups », explique Bernard Bégaud, professeur de pharmacologie à Bordeaux.

Deux dîners à 500 000 euros

Les déclarations des industriels sont en tout cas peu contrôlées. Et les manquements encore moins sanctionnés : si la base Transparence santé recense des millions de déjeuners (en moyenne : 40 euros), au CHU de Bordeaux, en 2018, plus de 500 repas affichaient une valeur supérieure aux recommandations officielles (60 euros). En 2018, sur l'ensemble des déclarations, 300 000 conventions ne font apparaître ni avantage ni rémunération, aucun montant traçable, sans que l'on sache s'il s'agit d'erreurs de saisie ou d'une volonté de masquer des informations.

Certains laboratoires sous-traitent cette tâche, au risque d'erreurs supplémentaires. Nous avons ainsi relevé deux dîners à 500 000 euros (!), 14 mentions de cadeaux et d'échantillons (interdits), des identifiants professionnels faux ou absents… Suite aux questions de notre collectif de journalistes sur une multitude d'erreurs, la société Janssen France a annoncé un audit de son prestataire.

L'autre défaut majeur du dispositif est qu'il est mal adapté aux montages dans lesquels s'inscrivent les relations entre professionnels de santé et industriels, ce qui induit une probable sous-estimation. En effet, beaucoup d'entre elles passent par des structures tierces ou des intermédiaires. Ainsi, des milliers d'associations de médecins (Association des néphrologues de Besançon, Association pour le développement de l'anesthésie réanimation méditerranéenne…) reçoivent elles aussi des millions d'euros des laboratoires. Impossible de savoir précisément qui a bénéficié de cette manne et pourquoi.

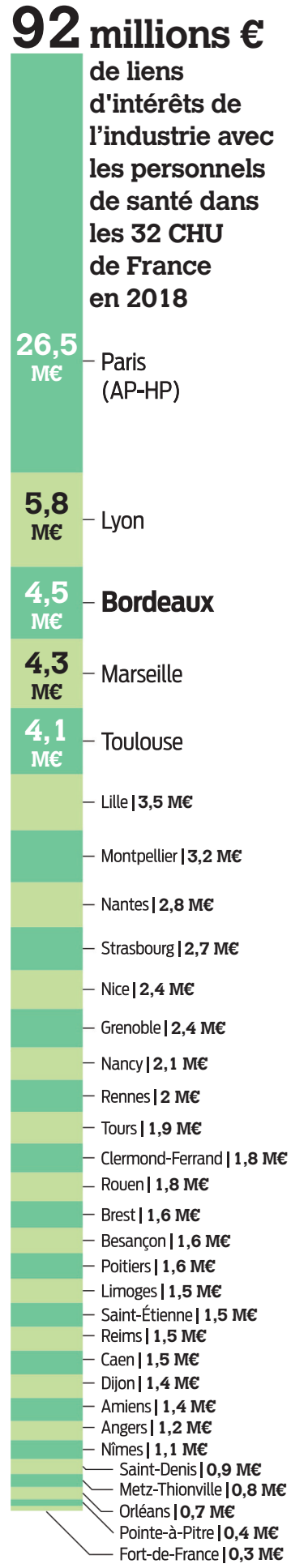
Une nébuleuse d'intermédiaires

Le passage par des structures tierces est fréquent dans la recherche clinique. Souvent financée par l'industrie, elle octroie aux médecins qui y participent des « honoraires d'investigateurs ». Par exemple, jusqu'à récemment à Bordeaux, un groupement d'intérêts économiques (GIE) – en cours de dissolution – se chargeait de faire l'interface entre l'industrie et les médecins. « En 2018, nous avons géré pour près d'1,8 million d'euros d'honoraires d'investigateurs », explique le professeur Nicholas Moore, ancien directeur de la structure. Chaque médecin pouvait ouvrir un compte sur lequel étaient versés les honoraires. Lorsqu'il partait ensuite en congrès, il pouvait utiliser ce compte pour se rembourser.

Un début de centralisation probablement plus vertueux que la nébuleuse d'associations qui ont longtemps eu l'apanage de ce type de service. « L'avantage était que nous étions sûrs que les honoraires ne pouvaient servir qu'à des dépenses liées à l'activité médicale ou de recherche », explique Nicholas Moore. Mais les laboratoires n'étant tenus de déclarer que les contrats avec le GIE, il est dès lors presque impossible pour le public de connaître le bénéficiaire final de ces sommes. « Faut-il mettre ces honoraires pour des recherches qui bénéficient aux patients sur le même plan que des contrats bidons passés par des médecins pour faire la pub de médicaments ? » s'interroge le professeur Moore qui pointe l'avantage d'une structure ayant pignon où l'institution est impliquée.

« Le problème c'est qu'on a un système où des couillons vont se faire embêter parce qu'ils se sont fait payer un croissant par un labo. Alors que des sommes importantes circulent encore par le biais d'associations dont certaines sont parfois domiciliées chez des médecins, voire même chez des membres de leur famille », peste un autre professionnel.

En 2011, Xavier Bertrand propose une loi censée répondre au scandale du Mediator. PHOTO ARCHIVES PASCAL GUYOT/AFP



Source : Base Transparence Santé SO infographie

SUR SUDOUEST.FR

TOUTES NOS ENQUÊTES

Dans notre dossier en ligne, l'association Formindep souligne dans une interview « les efforts rares et timides » des CHU français dans la prévention des conflits d'intérêts et évoque des solutions pour améliorer les pratiques du monde de la santé. Parcourez également en infographie les liens d'intérêts d'un médecin. Repas, déplacements, congrès et rémunérations : observez comment se nouent les contacts entre les professionnels et les industries de la santé. Les journalistes de la presse quotidienne régionale ont aussi passé en revue le poids de l'influence de l'industrie pharmaceutique dans plus d'une quinzaine de CHU à travers la France. Retrouvez notre revue de presse en ligne.

SUD OUEST.fr
Retrouvez l'ensemble de notre dossier et les infographies interactives sur notre site.

Transparence Santé : le statu-quo

Au terme de notre enquête, notre collectif de journalistes a adressé une quinzaine de questions mardi dernier à la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Nous souhaitions connaître son point de vue sur la gestion de la base « Transparence Santé » et les évolutions éventuelles envisagées pour ce dispositif présenté comme central lors de sa création. Nous souhaitions également connaître son regard sur le poids de l'industrie dans la formation des médecins, documenté par notre enquête, et sur la virulente critique formulée il y a quelques semaines par la Cour des comptes sur l'opacité du dispositif de formation continue des médecins. Nos questions portaient également sur les possibilités d'un meilleur encadrement au sein des hôpitaux et d'une sensibilisation accrue des professionnels de santé et des étudiants à la question des conflits d'intérêts.

Le cabinet d'Agnès Buzyn nous a adressé hier après-midi un court « recueil de la position de la ministre » que nous reproduisons intégralement:
« Si l'industrie des produits de santé est essentielle à la médecine, le choix des prescripteurs ne doit dépendre que de l'intérêt démontré du médicament pour la personne malade. Les conflits d'intérêts, en ce qu'ils font peser un doute sur l'expertise scientifique, doivent impérativement être empêchés. Avec la loi Santé du mois de juillet 2019, nous avons étendu l'obligation des déclarations des liens d'intérêts entre les industriels et les influenceurs, incluant les influenceurs du numérique, et nous avons étendu les dispositifs anti-cadeaux aux étudiants en santé ainsi qu'aux conseils nationaux professionnels ».
De son côté, le Comité de déontovigilance des entreprises du Médicament (Leem) estime que « la base Transparence santé ne suffit pas ». « On en a assez de cet outil non co-construit avec les entreprises du médicament, qui fonctionne mal, et à cause duquel les entreprises continuent à prendre des coups ». Le syndicat des entreprises du médicament se dit par ailleurs vigilant sur « la qualité des liens entre les entreprises et les médecins. Le Codeem a interdit par exemple, pour l'organisation de manifestations, les lieux ludiques ou somptuaires. Et on veille à interdire les soirées de gala, les dîners avec spectacle, qui ne se font quasiment plus ». « Aujourd'hui, les financements des laboratoires couvrent notamment les essais cliniques de nouveaux médicaments qu'il est important de conserver en France pour que les patients bénéficient au plus vite des innovations » précise le comité qui appelle à une « règle nationale de plafonnement des rémunérations » concernant les collaborations entre médecins et laboratoires.

SILENCE À LA FAC

Les Conférences nationales des doyens de médecine ont voté une Charte éthique et déontologique en 2017. Nous aurions aimé évoquer la concrétisation de cette charte à Bordeaux. Nous aurions également souhaité interroger le collège « Sciences de la Santé » de l'Université de Bordeaux pour évoquer la question de la formation déontologique des étudiants, les partenariats noués par la fac de Bordeaux (et la Fondation Bordeaux Université) avec les entreprises du médicament. Malheureusement, depuis notre premier contact le 6 novembre et malgré les relances, aucun rendez-vous n'a pu nous être proposé, même téléphonique. Nous regrettons ces silences et l'impossibilité de fournir à nos lecteurs une information complète sur le sujet. La Conférence des directeurs généraux de CHRU et le Snitem, qui fédère les entreprises de dispositifs médicaux, ont également refusé de s'exprimer.